

EH — TRATAR O FATOR + LACTULOSE

GRADUAÇÃO (CRITÉRIOS DE WEST HAVEN)

Grau	Consciência / Cognição	Achados
Mínima	Sem alteração clínica evidente	Déficit apenas em testes psicométricos
I	Leve: inversão do sono, euforia/ansiedade, déficit de atenção	Tremor fino, incoordenação leve
II	Letargia, desorientação no tempo, comportamento alterado	Asterixis (flapping) evidente, fala arrastada
III	Sonolência/estupor, confusão acentuada, desorientação no espaço	Asterixis pode estar presente, hiperreflexia
IV	Coma	Sem resposta a estímulos; proteger via aérea

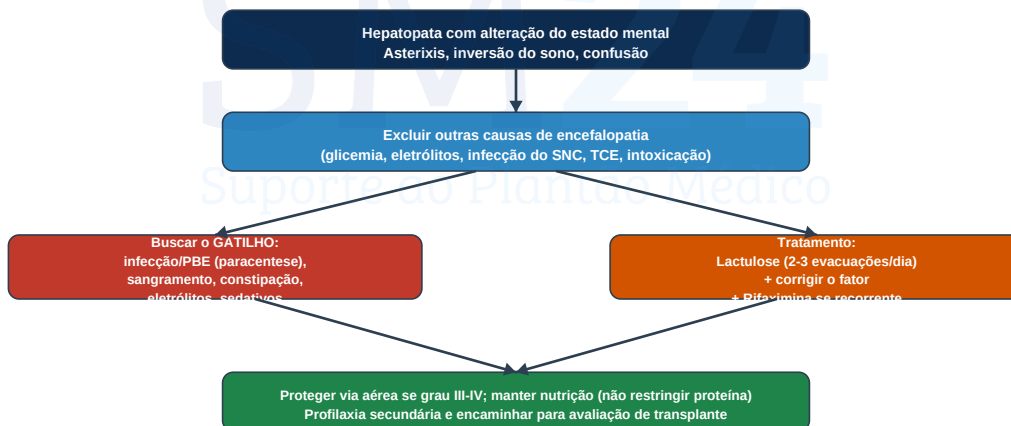
O MAIS IMPORTANTE: ACHAR O FATOR PRECIPITANTE

A EH QUASE SEMPRE TEM UM GATILHO

- Infecção (incluindo PBE — peritonite bacteriana espontânea): pesquisar SEMPRE com paracentese se ascite
- Constipação e sangramento digestivo (carga de nitrogênio no intestino)
- Distúrbios hidroeletrólíticos (hipopotassemia, alcalose, desidratação por diurético)
- Uso de sedativos/benzodiazepínicos e opioides
- Lesão renal aguda, desidratação, excesso de diurético, paracentese de grande volume sem albumina
- Tratar o fator precipitante é tão importante quanto a lactulose — buscar ativamente
- Hiperamonemia apoia o quadro, mas o nível de amônia NÃO se correlaciona bem com a gravidade nem guia o tratamento

ABORDAGEM DA EH

EH — EXCLUIR OUTRAS CAUSAS + TRATAR O GATILHO



TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

Rx LACTULOSE, RIFAXIMINA E SUPORTE

Lactulose: 25 mL VO 1-2/2h até evacuar, depois titular para 2-3 evacuações pastosas/dia (primeira linha)
Lactulose por enema (300 mL em 700 mL de água) se o paciente não tolera VO ou está rebaixado
Rifaximina 550 mg VO 12/12h: associada à lactulose na EH recorrente (reduz recidivas)
Tratar o fator precipitante: antibiótico para infecção/PBE, repor potássio, suspender sedativos, tratar sangramento
Manter aporte proteico adequado (NÃO restringir proteína — piora a desnutrição); preferir proteína vegetal/laticínios
Proteger a via aérea (IOT) no grau III-IV com risco de aspiração
Evitar/retirar benzodiazepínicos; usar flumazenil apenas se EH precipitada por benzodiazepínico

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E MITOS

Diferenciais

- Hipoglicemia (sempre checar a glicemia)
- Distúrbios eletrolíticos e uremia
- Hematoma subdural (etilista, queda) e AVC
- Intoxicação por álcool/drogas e abstinência
- Encefalopatia de Wernicke (repor tiamina no etilista)
- Seps e infecção do SNC

Mitos a Evitar

- NÃO restringir proteína de forma prolongada (agrava a desnutrição/sarcopenia)
- Amônia sérica NÃO deve guiar o tratamento isoladamente
- Flumazenil de rotina não é indicado (só se gatilho por BZD)
- Não atribuir todo rebaixamento à EH sem excluir outras causas
- Lactulose em excesso pode causar desidratação e hipernatremia
- Não esquecer a paracentese diagnóstica no ascítico

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer a EH no hepatopata (asterixis, inversão do sono, confusão) e graduar por West Haven
- ☐ Excluir outras causas de alteração mental (glicemia, eletrólitos, infecção do SNC, TCE)
- ☐ Buscar ATIVAMENTE o fator precipitante — paracentese se ascite (excluir PBE)
- ☐ Lactulose titulada para 2-3 evacuações/dia; rifaximina na EH recorrente
- ☐ Não restringir proteína; proteger a via aérea no grau III-IV
- ☐ Tratar o gatilho, instituir profilaxia secundária e avaliar transplante

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Cirrótico com ascite chega confuso e com asterixis. Além de iniciar lactulose, qual investigação NÃO pode faltar?

- A) Tomografia de crânio para todos
- B) Paracentese diagnóstica para excluir peritonite bacteriana espontânea e buscar o fator precipitante
- C) Dosagem isolada de amônia para guiar a conduta
- D) Endoscopia imediata em todos
- E) Restrição proteica rigorosa

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o tratamento de primeira linha da encefalopatia hepática?

- A) Rifaximina isolada
- B) Lactulose titulada para 2-3 evacuações pastosas por dia
- C) Restrição proteica permanente
- D) Flumazenil de rotina
- E) Neomicina oral em altas doses

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Sobre a restrição proteica na EH, qual afirmação é correta?

- A) Deve ser rigorosa e prolongada em todos os pacientes
- B) Não deve ser restrição prolongada, pois agrava a desnutrição/sarcopenia; manter aporte proteico adequado
- C) A proteína deve ser totalmente suspensa por 1 semana
- D) Apenas proteína animal melhora a EH
- E) A dieta não influencia em nada

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Por que a dosagem de amônia sérica não deve guiar isoladamente o tratamento da EH?

- A) Porque a amônia nunca está elevada na EH
- B) Porque o nível de amônia não se correlaciona bem com a gravidade nem com a resposta ao tratamento
- C) Porque a amônia só se eleva no coma
- D) Porque a amônia é um marcador de infecção
- E) Porque a amônia é normal em todos os cirróticos

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Qual medicação é associada à lactulose para reduzir recorrências da encefalopatia hepática?

- A) Rifaximina
- B) Omeprazol
- C) Espironolactona
- D) Propranolol
- E) Furosemida

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Em todo cirrótico ascítico com EH, a paracentese diagnóstica é mandatória para excluir PBE (causa frequente e tratável de descompensação). Buscar o fator precipitante é tão importante quanto iniciar a lactulose.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A lactulose é o tratamento de primeira linha da EH, titulada para 2-3 evacuações pastosas por dia (reduz a produção e a absorção de amônia no cólon). A rifaximina é associada na EH recorrente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A restrição proteica prolongada agrava a desnutrição e a sarcopenia do cirrótico e NÃO melhora a EH. Deve-se manter aporte proteico adequado, preferindo proteína vegetal e laticínios, e tratar o fator precipitante.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O nível de amônia sérica não se correlaciona bem com a gravidade clínica da EH nem com a resposta ao tratamento. O diagnóstico e o manejo são clínicos (graduar, tratar o gatilho, lactulose) — a amônia não deve guiar a conduta isoladamente.

QUESTÃO 5 → Resposta: A

A rifaximina (antibiótico de ação intestinal) é associada à lactulose na EH recorrente, reduzindo a produção de amônia pela flora intestinal e diminuindo as recidivas e internações.

SM24
Suporte ao Plantão Médico